

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

Introducción

Parálisis flácida de toda la musculatura hemifacial como consecuencia de una lesión en el trayecto periférico del **nervio facial o séptimo par craneal**. Lo más importante es descartar que sea una parálisis de causa central.

Causas: Idiopática (parálisis de Bell), infecciosa (Síndrome de Ramsay Hunt), traumática.

Diagnóstico

- **NOTA:** Realizar exploración neurológica general.

- **Parálisis facial central:** lesión a nivel supranuclear. Parálisis hemifacial completa con afectación frontal ipsilateral.
- **Parálisis facial periférica:** afectación hemifacial que conserva la función motora frontal.

Exploración general ORL: otoscopia y búsqueda de vesículas en el CAE (Ramsay-Hunt) o si hay patología colesteatomatosa. Si otoscopia normal, solicitar valoración por ORL. Acumetría. Exploración neurológica: estructurada.

Diferencia entre parálisis facial periférica y parálisis facial central

Parálisis facial periférica	Parálisis facial central
• Asimetría facial, dificultad para elevar la ceja y cerrar el ojo • Signo de Bell positivo • Comisura bucal desviada hacia el lado sano. • Alteración de los sentidos y otalgia	• Musculatura conservada de la frente y párpado superior • Signo de Bell negativo

Causas principales de parálisis facial periférica y central

Parálisis facial periférica	Parálisis facial central
• Idiopática o parálisis de Bell, síndrome de Ramsay-Hunt, esclerosis múltiple, mononucleosis, fractura del hueso temporal (peñasco) y basicraneales, cirugía de oído, otitis media, herpes simple tipo 1 (VHS-1), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).	• ACV, infecciones, tumores.

Clínica: Es común (parálisis de Bell): Instauración brusca con aplanamiento de pliegue nasolabial, caída de comisura bucal, puede existir antecedente de cuadro vírico. Signo de Bell. Disgeusia o Algiacusia.

Valorar según Escala de House-Brackman

GRADO I: Normal	Normal
GRADO II: Leve	Asimetría bucal
GRADO III: Moderado	Cierre ocular con mínimo esfuerzo
GRADO IV: Moderado-severo	Cierre ocupar con esfuerzo máximo
GRADO V: Severo	Cierre de ojos incompleto (Signo de Bell)
GRADO VI: Total	Ningún movimiento

Pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, amilasa, PCR.
- Coagulación básica.
- TAC craneal: si sospecha de parálisis facial no idiopática o patología neurológica acompañante.

Tratamiento

- Prednisona 1mg kg/día pauta descendente durante 1 mes.
- Si Herpes: Añadir Aciclovir 800 mg cada 4h durante 7 días (omitir dosis nocturna) o Famciclovir (Famvir) 500 mg cada 8h durante 7 días o Valtrex (valaciclovir) 500 mg cada 12h 7 días.
- Lagrimas artificiales a demanda
- Protección ocular (Parche por las noches).
- Seguimiento por ORL.

Bibliografía

- J. Valls-Solé Facial palsy, postparalytic facial syndrome, and hemifacial spasm Move Disord, 17Suppl (2002), pp. 49-52
- T.L. Yen,C.L.W. Driscoll,A.K. Lalwani Significance of House-Brackmann facial nerve grading global score of differential facial nerve function Otol Neurotol, 24 (2003), pp. 118-122

HIPOACUSIA BRUSCA

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

Introducción

Pérdida auditiva neurosensorial superior a 30dB en 3 o más frecuencias consecutivas, en un tiempo de instauración inferior a las 72 horas. Etiología desconocida, teoría viral.

Diagnóstico

Otoscopia normal. Acumetría: Rinne positivo, Weber lateralizado al oído sano.

Ante estos hallazgos valoración por ORL.

Tratamiento

Tratar a todos los pacientes diagnosticados en los primeros 45 días tras el inicio del episodio.

- Prednisona o metilprednisolona oral empezando con 1mg/kg peso descendiendo pauta cada 5 días hasta completar ciclo de 25 días.
- Audiometría tonal de control a la semana, al mes y al año.
- Controles con ORL

Bibliografía

- Mettrailer AM, Babu SC. Management of sudden sensorineural hearing loss. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2016; 24: 403-6
- García Berrocal JR, García Arumí A, Herrera M, Lavilla MJ, Amarillo E, Del Toro L, Plaza G. 2º Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita (SS) en España. 2016.

VÉRTIGO PERIFÉRICO EN URGENCIAS

M. Tucciarone, P. Pinacho Martínez, González-Orús Álvarez-Morujó R.

¡RECUERDA!

- La base del abordaje del vértigo en urgencias son la HISTORIA CLÍNICA y la EXPLORACIÓN FÍSICA.
- La prioridad en todo momento debe ser DESCARTAR ORIGEN CENTRAL.

Introducción

El vértigo es la sensación ilusoria de movimiento del entorno o del propio cuerpo que no se asocia a pérdida de consciencia. Puede ser de naturaleza central o periférica (lo más frecuente).

El vértigo y el mareo son síntomas muy frecuentemente referidos por los pacientes en urgencias; en ocasiones el diagnóstico puede ser muy complejo y por esto es esencial dominar su diagnóstico diferencial.

Existen numerosas entidades clínicas que pueden cursar con vértigo periférico. Sin embargo, el manejo en urgencias tiene que mirar esencialmente a diferenciarlo de los vértigos de causa central.

En este capítulo nos centraremos en el abordaje del síndrome vestibular agudo (SVA).

El SVA es un cuadro de mareo con sensación intensa de giro de objetos o del propio cuerpo, de aparición brusca, que se acompaña de náuseas o vómitos, inestabilidad para la marcha, nistagmo e intolerancia a los movimientos cefálicos, con una duración de 24 horas o más. En general el SVA aparece de manera aislada (con o sin hipoacusia); su principal causa es periférica (neuritis vestibular o laberintitis), pero lo fundamental es saber diferenciarlo de las causas centrales. Siempre se ha dado mucha importancia a las pruebas de imagen, siendo el TC cerebral la prueba más utilizada en urgencias para estos pacientes; sin embargo esta prueba presenta una baja sensibilidad en el diagnóstico del infarto agudo que disminuye a menos del 20% si nos referimos a infartos de fosa posterior. Una prueba más sensible sería la RMN que solo tiene una tasa de falsos negativos de aproximadamente el 12 %, aunque en las urgencias generalmente no se dispone de esta prueba.

Una correcta exploración otoneurológica es lo más importante para el manejo de un SVA en urgencias, y debido a esto presentamos un protocolo estandarizado útil en el diagnóstico diferencial¹.

Protocolo HINTS + standing

(Head-Impulse, Nystagmus, Test of Skew)

- **Maniobra de impulso cefálico (HIT):** exploración de la integridad del reflejo vestíbulo-ocular (VOR) realizando giros rápidos de la cabeza del paciente, con angulación de 20grados mientras el mismo fija la nariz del explorador; en déficits vestibulares severos suele ser positiva (97-100%). Un HIT negativo en un SVA tiene que hacer sospechar una causa central.
- **Nistagmo espontáneo:** la presencia de un nistagmo evocado por la mirada (cambio de dirección del nistagmo según cambio en la mirada) es altamente sugestivo de patología cerebelosa y troncoencefálica.
- **Skew test (cover test):** se realiza una oclusión ocular alternante y se observan los movimientos correctivos del ojo descubierto en el plano vertical; si el signo es positivo es

sugestivo de patología central.

- **Standing:** en los pacientes que no sean capaces de levantarse y deambular sin ayuda se sospechará un vértigo central².

Diagnóstico

El diagnóstico del vértigo periférico es esencialmente clínico, basado en una buena anamnesis y una detallada exploración³. De forma muy esquemática vamos a clasificar en función de la repetición de los episodios de vértigos y en función de la asociación con hipoacusia.

CRISIS ÚNICA	CRISIS RECURRENTES
CON HIPOACUSIA • Con afectación coclear (laberintitis) • Neuritis cocleovestibular (Sd. Ramsay Hunt)	CON HIPOACUSIA • Enfermedad de Ménière • Migraña tipo basilar • Enfermedad autoinmunitaria de oído interno • Neurosífilis-otosífilis • Fístula perilinfática
SIN HIPOACUSIA • Neuritis vestibular	SIN HIPOACUSIA PROVOCADAS: • VPPB: por la postura • Fístula perilinfática: por la presión ESPONTANEAS: • Migraña vestibular • vértigo paroxístico de la infancia

Patología	Antecedentes	Causa	Inicio	Duración	Nistagmo
Neuritis vestibular	-proceso viral	-reactivación VSH 1 - vascular	- brusco	Horas al día	Localizador
VPPB	- TCE - cirugía de oído - neuritis vestibular - espontanea	-canalitis -cupololitis	- movimientos cefálicos	<1 minuto	Localizador
E. de Ménière	- crisis recurrentes	-Hydrops endolinfático	- síntomas otológicos (hipoacusia acúfenos, plenitud ótica...)	20 minutos/horas	No localizador
Fístula perilinfática	- TCE - Cirugía de oído - espontanea	- comunicación anómala entre oído medio e interno	- Valsalva, aumento presión en CAE, ruidos intensos (CSS)	Minutos/horas	Localizador

Tratamiento

El tratamiento del SVA es fundamentalmente sintomático: consiste en tratamiento antiemético y con sedantes vestibulares en la fase aguda, máximo 3-4 días, para no impedir la aparición de la compensación central del déficit vestibular, y en el tratamiento de soporte con fluidoterapia para la posible deshidratación/ desnutrición acompañante.

En el caso del VPPB, el especialista ORL se encargará de realizar las específicas maniobras de reposición.

Después de la resolución en urgencias del SVA el ORL se encargará del seguimiento periódico de los pacientes en las consultas.

Fármaco	Dosis	Precauciones
Diazepam	VO: 2.5-10mg/6-12h IV: 5-10mg/8-12h	Glaucoma, adicción, embarazo, sedación
Clonazepam	VO: 0,5mg/8h	Idem
Tietilperacina	VO: 5.10mg/8h SC: 10mg/8h	Enf. Hepática, No usar con benzodiacepinas
Metoclopramida	VO: 5-10mg/24h IM IV: 10mg/4-6h	Enf hepática o renal, obstrucción inestinal, feocromocitoma
Ondasentron	VO: 8mg/12h	
Sulpirida	VO: 50mg/8h IM: 100mg/12h	

VO: Vía Oral. IM: Intra Muscular. IV: Intra Venoso.

Bibliografía

- Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ, Hsieh YH. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular síndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging. Stroke. 2009 Nov; 40(11): 3504-10.
- Vanni S, Pecci R, Casati C, Moroni F, Risso M, Ottaviani M, Nazerian P, Grifoni S, Vannucchi P. STANDING, a four step bedside algorithm for differential diagnosis of acute vértigo in the Emergency Department. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014 Dec; 34(6): 419-26.
- Soto-Varela A, Aran-González I, López-Escámez JA et al. Peripheral vértigo classification of the otoneurology Committee of the Spanish Otorhinolaryngology Society: diagnostic agreement and update (versión 2-2011). Acta Otorrinolaringol Esp 2012 Mar-Apr; 63 (2): 125-31.